

Fecha Última Actualización: 07-10-2024 12:41:30

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Sofía De Las Mercedes León Gutiérrez **Rut** : 11.393.835-8 **N° Archivo** : A262781
Edad : 55a 5m 29d **Fecha Nacto**: 08/04/1969 **Sexo** : Femenino
Dirección : Tocornal 739 Los Aromos **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 978944941

N° Epicrisis
415717

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 06/09/2024 21:29 **Días Estadía**: 31
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso) **Fecha Egreso** : 07/10/2024 12:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

AM: HTA, ciática, obesidad mórbida

LCFA (EPOC vs Asma). Usuaría 0.5lts O2 nocturno 15 hrs

ICC Derecha (Último EcoTT 10/2022 --> VD Dilatado, Hipertrofia pared libre, Función sistólica derecha normal, PSAP 50 mmHg. VI normal. MIBI 06/2023 mínima isquemia anteroapical (3%). CNG 11/2023 Sin lesiones

AQ: 3 CCA, RATT de íleon terminal por perforación reparación con malla de vicryl (2022)

Fármacos: Salbutamol SOS, Berodual 2 cada 12 hrs, Pregabalina, Tramadol, Aspirina, atorvastatina, Carvedilol 1 - 1/2, Furosemida 20 mg, Metformina, Losartán

Alergias: (-)

Hábitos: TBQ (+) IPA 15, OH (-), Drogas (-)

Hospitalizaciones recientes:

CNG electiva en 2023

Obstrucción Intestinal 2dario a hernia pared abdominal en 2022 (Hospitalizada en UCI, cura inotrópica, Cor Pulmonale, Shock Séptico por E. Cloacae en Urocultivo)

Social: Trabaja como manipuladora de alimentos

ANAMNESIS

Consulta en urgencias por 4 días de dolor abdominal, náuseas y vómitos, asociado a ausencia de deposiciones de 4 días. No se constata fiebre o síntomas de otros sistemas. Al examen físico destaca hernia incisional gigante, reductible al tacto, sin signos de irritación peritoneal. Ingresa hipotensa y taquicárdica, afebril y sin requerimientos de O2 suplementario.

En los exámenes de ingreso destaca hiponatremia hipoclorémica severa, PCR elevada (211), e insuficiencia renal aguda prerrenal. Se realiza un TAC de abdomen y pelvis compatible con "íleo mecánico de alto grado de intestino delgado con puntos de transición al interior del saco herniario de hernia de pared abdominal anterior con un "asa cerrada" en su interior. No hay signos sugerentes de sufrimiento de asas intestinales.". En este contexto ingresa en primera instancia a Cirugía para manejo médico y reparación programada de hernia dado dificultad quirúrgica, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, constantemente hipotensa, con empeoramiento de llene capilar y vómitos biliosos, por lo que ingresa a pabellón.

En pabellón se constata íleo mecánico de alto grado, con punto de transición en relación a brida ubicada en saco herniario, con perforación contenida. Sin signos de isquemia intestinal. Se realiza sección de brida gruesa y de segmento perforado. Dada inestabilidad hemodinámica se dejan cabos sueltos y se instala abthera (dispositivo para laparotomía contenida). Se volemiza 2 litros de cristaloides y se ingresa a UCI. Se recibe hipotensa, taquicárdica, con saturación límite, CRT 10seg, lívides hasta

Fecha Epicrisis : 07/10/2024 12:41

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 07-10-2024 12:41:30

Página 2 de 4

pecho. En SAS 1, con Fentanilo-Midazolam y con NAD a 0,5ug/kg/min

IMÁGENES DE INGRESO

TAC AP 06/09: Hallazgos compatibles con un íleo mecánico de alto grado de intestino delgado con puntos de transición al interior del saco herniario de hernia de pared abdominal anterior con un "asa cerrada" en su interior. No hay signos sugerentes de sufrimiento de asas intestinales.

EXÁMENES DE INGRESO

06/09: GB 13.560 N 65,8%; Hb 14,8; PCR 211,8; CREA 4,31; BUN 75,8; Ac láctico 16,5; pH 7,4; Na 124 K 4,19 Cl 80

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO (UPC)

- 1) Shock Distributivo (Séptico) + Hipovolémico
 - Íleo Mecánico alto grado (Bridas + saco herniario gigante pared abdominal
 - perforación intestinal pequeña contenida
 - POP 07/09 Laparotomía exploradora (Reducción hernia + sección perforación con cabos suelos + Abthera post)
- 2) AKI KDIGO III (Prerrenal)
- 3) Antecedentes

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

1.Hemodinamia: al ingreso hospitalario (UPC) con shock de tipo distributivo + hipovolémico. Se volemizó con cristaloides (1000cc adicionales) y albúmina, con lo que presenta signos de cor pulmonale agudo por lo que requirió milrinona + NAD + Vasopresina. En este contexto se manejó como shock cardiogénico + séptico. Eco-bedside con signos de HTP crónica, elevación de TUS por injuria miocárdica, mejoría significativa con h emofiltración de alto volumen y terapia depletiva. Logra suspensión de vasopresina el 11/09 y NAD el 15/09, Milrinona 16/09. Además durante estadía con múltiples reintubaciones, y uso transitorio de vasoactivos en dicho contexto.

Último día de vasoactivos 29/9. Persiste con hipotensión que no responde a volemización. Se realiza angioTC para descarte de TEP, sin hallazgos sugerentes de enfermedad tromboembólica.

2.Ventilatorio: IOT 07/09- 16/09 posterior a pabellón y por shock. Sale a VMNI. Inicialmente weaning fallido por edema de vía aérea superior, reintubándose el 17/09. Se administra dexametasona por 3 días, y nuevamente el 20/9 se extuba, saliendo a CNAF. Inicialmente sin incidentes, sin embargo evolucionando con sialorrea y mal manejo de secreciones, por lo que se decide reintubar el 21/09. Previo nuevo intento de extubación se inicia corticoides e IBP por antecedente laringoespasma, logrando extubación el 25/09 sin incidentes.

Destaca antecedente de LCFA, aparente manejado como EPOC con compromiso cardíaco y uso de oxígeno diurno. Durante estadía hospitalaria con varias interurrencias infecciosas. AngioTC de tórax sin signos de TEP, con signos de enfisema sugerente de EPOC. últimos 5 días sin requerimiento de O2 suplementario.

3.Infeccioso: Al ingreso, en contexto de peritonitis secundaria recibió Ceftriaxona/Metronidazol empírico por 9 días, la que se rota a ampicilina por 7 días adicionales por cultivos positivos para Enterococcus Casseliflavus y S. Haemolyticus (S. Haemolyticus en teoría cubierto y tratado con ceftriaxona). El 20/9 neumonía por SAMR tratada con vancomicina por 5 días. En traslado a UTIM con clínica de traqueobronquitis por P Mirabilis MS y SAMR (S a cotri), resto negativo. El 27/9 se inició Imipenem + vancomicina empírica, esta última suspendida con HC (-). Se ajusta terapia a cotrimoxazol el 1/10 para cobertura ambos MO.

Paciente portadora NDM/KPC y Van B.

4.Quirúrgico: Paciente con abdomen quirúrgico. En primer tiempo cirugía de control de daños + laparotomía contenida (abthera). En segundo tiempo anastomosis entero-enteral lateral. Con adecuada evolución postoperatoria.

El 11/09 va a pabellón para eventual cierre, retornando con cierre de piel únicamente, con gran defecto herniario y drenajes en FID. Evolución favorable y retiro de drenaje el 20/9.

Se mantiene en seguimiento por cirugía, sin cierre de aponeurosis abdominal por gran defecto sin posibilidad de cierre actualmente, con plan de cierre en 1 año. Sin contraindicación para rehabilitación. Seguimiento por equipo al alta. Tercio inferior de defecto con leve distanciamiento de bordes, afrontadas post-curación con tape. Se indican curaciones 3 días por semana al alta.

5.Nefrológico: Presentó AKI KDIGO III que requirió HFAV 08/09, desde entonces respuesta favorable, con diuresis depurativa y

Fecha Epicrisis : 07/10/2024 12:41

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 07-10-2024 12:41:30

Página 3 de 4

manteniendo furosemida para balance negativo. Actualmente sin falla renal, no es conflicto.

6.Neurológico: Tuvo difícil despertar por agitación por delirium hiperactivo, requerimiento de precedex + haldol por horario, tras inicio de régimen oral se traslapa a risperidona con lo que se mantiene en el momento de su egreso.

7.Nutricional: Se mantuvo en régimen cero hasta el 17/09 donde se inicia nutrición enteral por SNG, en plan de vigilar síndrome de realimentación considerando ayuno prolongado, no fue conflicto. El 07/10 se retira SNG dada adecuada tolerancia a sólidos.

ÚLTIMOS EXÁMENES

07/10: Alb 3, Ca 9, Crea 0.7, BUN 13.2, P 4.3, LDH 178, PCR <1, INR 1.02, TTPA 38, 137/4.1/104,

03/10: Alb 2.8 Ca 8.9(8.6) P 4.5(2.9) PCR 1.6(3.2) ELP 138/4,14/105 Crea 0.6(0.47) BUN 13.8 Hto 30.8 Hb 10.1 GB 5.85 PLQ 281

DIAGNÓSTICOS AL ALTA

1.Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica resuelta

2.Crítica crónica

VMI 07-16/09, 17-20/09, 21-25/09

Miopatía de paciente crítico

Trastorno de deglución resuelto

3.POP íleo mecánico con perforación intestinal.

Reducción hernia + sección perforación con cabos sueltos + A b t h e r a 07/09.

2do tiempo: Anastomosis entero-enteral lateral. Sin cierre de aponeurosis 11/09.

4.RESUELTOS: NAVM por SAMR, Shock mixto, Peritonitis por Enterococcus Casseliflavus, AKI KDIGO III resuelta, Obs isquemia ESI resuelta

5.ANTECEDENTES: HTA, ciática, obesidad mórbida, LCFA (EPOC vs Asma). Usuaría 0.5lts O2 nocturno 15hrs, ICC Derecha, OI 2022 por hernia abdominal

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico - Obstrucción intestinal

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

BUenas condicones generales, afebril, HDE

COMienod por boca llegando a requerimientos nutricionales

Plan Post Alta

Reposo relativo

Regimen hiposódico

Retomar Medicamentos de uso crónico:

- Brexotide 2 puff c/12 horas

- Berodual 2 puff c/ 6 horas

- Pregabalina 75 mg c/24 hrs

- Tramadol 150 mg c/12 hrs

- Metformina 850mg c/24 hrs

- Furosemida 40mg, medio comprimido, una vez al día

- Espironolactona 25mg, c/24 hrs

- Carvedilol 6.25mg, c/24hrs

- Omeprazol 20mg c/24 hrs AM

- Aspirina 100mg c/24 hrs, AM

- Atorvastatina 40mg, 2 comprimidos c/24 hrs PM

- Losartan 25mg, medio comprimido AM

- Paracetamol 1 gr SOS en caso de dolor o fiebre máximo c/ 8 hrs.

- Curaciones simples en zona abdominal tres veces a la semana en consultorio.

Fecha Epicrisis : 07/10/2024 12:41

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:28

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 07-10-2024 12:41:30

Página 4 de 4

- Control con equipo de cirugía digestiva al alta en CDT, llevar epicrisis.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Luis Cáceres Verdugo

INTERNO

Bec. Anibal Méndez Valded

Becado/Residente

Juan Opazo Cereceda

Médico Tratante (Staff)